주사 없이 먹는 GLP-1, 어디까지 왔나 ACHIEVE-3 직접비교 리뷰

신약 오포글리프론 vs 기존 먹는 약 세마글루타이드 · 1,698명 52주 머리를 맞댄 비교 — 아직 국내 승인 전, 미리 함께 읽어보는 연구 결과입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 '더 편한 당뇨약'이 계속 나올까요

당뇨는 흔하고, 오래 가고, 꾸준히 챙기기가 가장 어렵기 때문입니다

1/6

30세 이상 성인 당뇨병

여섯 명 가운데 한 명이 당뇨병입니다

1/3

65세 이상 당뇨병

세 명 가운데 한 명 — 나이가 들수록 흔해집니다

1/4

목표 혈당에 도달한 비율

당화혈색소 기준 — 네 명 중 세 명은 아직 목표 전

당화혈색소란

지난 2~3달의 평균 혈당을 보여주는 '혈당 성적표'입니다. 치료 효과를 이 숫자로 봅니다.

그래서 약이 바뀝니다

효과가 좋아도 맞기 불편하거나 챙기기 번거로우면 오래 못 갑니다. 주사로만 쓰던 GLP-1 치료가 '먹는 약'으로 바뀌는 이유입니다.

Tip · 유병률·조절률은 대략적인 숫자입니다 — 방향을 이해하는 데 쓰세요.

근거 · 대한당뇨병학회 당뇨병 팩트시트

GLP-1 — 식후 호르몬을 흉내 내는 약

원래는 주사로만 가능했던 치료입니다 — 몸에서 하는 일은 네 가지입니다

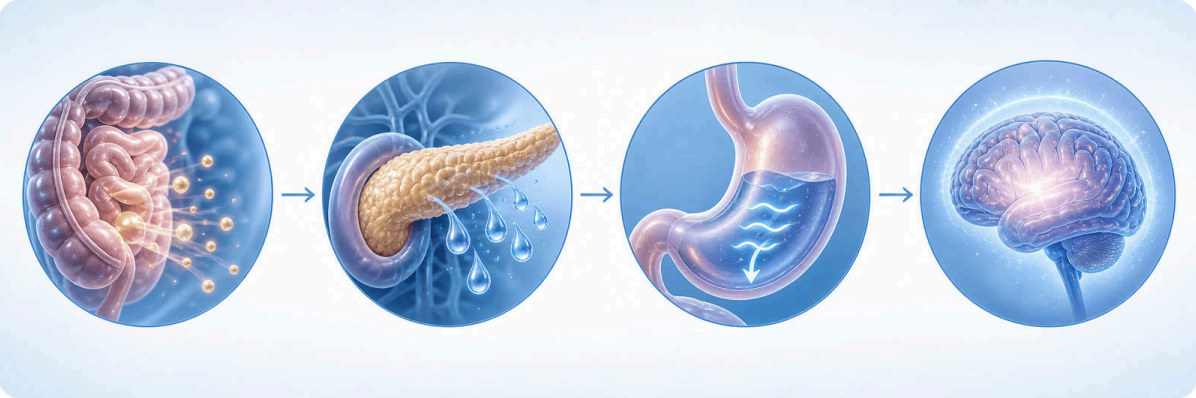


그림 · 장 → 췌장 → 위 → 뇌 순서로 약이 하는 일을 따라갑니다(설명용 그림).

두 알약 모두 같습니다 먹는 GLP-1 두 가지는 이 네 가지 작용이 같고, 알약을 만드는 방식만 다릅니다(다음 장).

1. **식사를 시작하면** 장
   장에서 나오는 GLP-1 호르몬 역할을 약이 더 강하고 길게 대신합니다.
2. **인슐린 분비를 돕고** 췌장
   혈당이 높을 때만 작동해 이 약만으로는 저혈당이 드뭅니다. 다만 설포닐우레아·인슐린과 함께 쓰면 저혈당이 생길 수 있습니다.
3. **위를 천천히 비우고** 위
   식후 혈당이 급히 오르는 것을 막습니다 — 메스꺼움이 생기는 이유이기도 합니다.
4. **식욕을 줄입니다** 뇌
   포만감 신호를 도와 혈당과 체중에 함께 작용합니다.

Tip · 저혈당약(설포닐우레아)이나 인슐린을 함께 쓰는 분은 약 조정이 필요할 수 있어 꼭 알려 주세요.

근거 · GLP-1 수용체 작용제 공통 작용 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3)

같은 GLP-1을 알약으로 — 만드는 방식이 다릅니다

같은 계열이지만 기술이 다릅니다 · mg 숫자는 서로 다른 약이라 직접 비교할 수 없습니다

기존 먹는 약 · 세마글루타이드 (7·14mg)

호르몬 조각(펩타이드)을 흡수를 돕는 성분과 함께 삼키는 방식입니다. 그래서 빈속 규칙이 까다롭습니다.

신약 · 오포글리프론 (12·36mg)

호르몬 조각이 아니라 작은 화학 분자입니다. 처음부터 먹는 약으로 만들어 위산에 강하고, 음식·물 제한이 없습니다.

처음으로 1년간 정면 비교

ACHIEVE-3는 이 두 알약을 같은 환자군에서 1년 동안 직접 비교한 첫 대규모 시험입니다. 신약은 아직 국내 승인 전입니다.

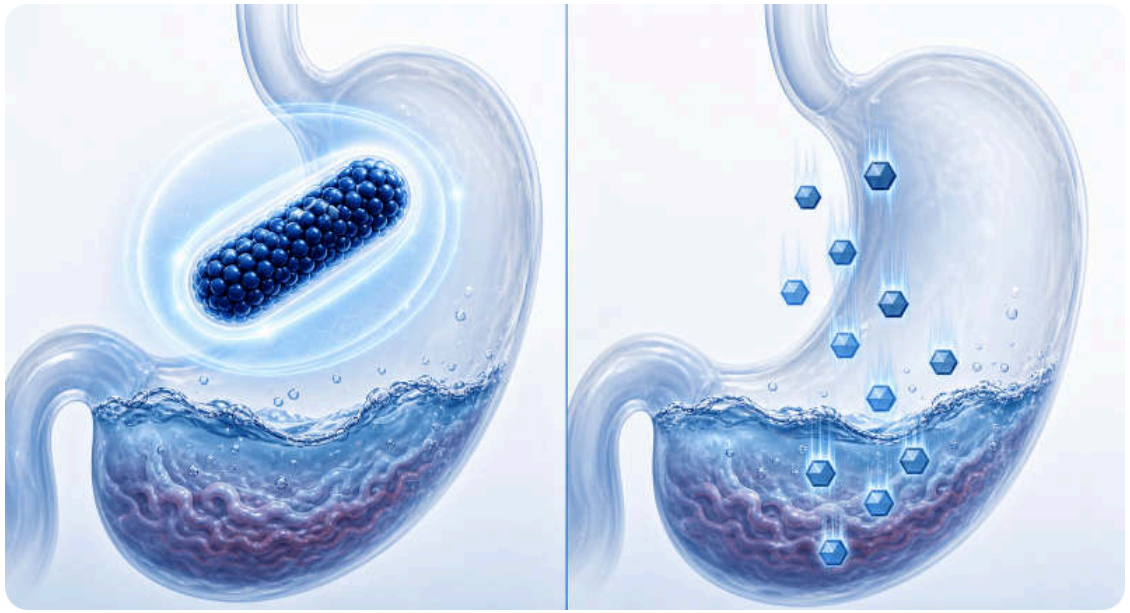


그림 · 왼쪽은 호르몬 조각 알약, 오른쪽은 작은 분자 알약이 위에서 녹는 모습입니다 (설명용 그림).

Tip · 용량 숫자(mg)가 크다고 더 센 약이라는 뜻은 아닙니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

매일 아침이 달라집니다 — 복용 규칙 비교

두 약 모두 좋은 선택지입니다 — 다만 일상에 얹는 부담이 다릅니다



그림 · 왼쪽은 약을 먹고 30분 기다리는 아침, 오른쪽은 바로 식사하는 아침입니다(설명용 그림).

무엇이 다른가 효과의 문제가 아니라 매일 아침 일상에 얹히는 부담의 차이입니다.

기존 먹는 약 · 세마글루타이드

아침 빈속에 물 반 컵 이하로 먹고, **30분 동안** 음식·음료·다른 약을 기다립니다. 규칙을 지키면 효과가 검증돼 있습니다.

신약 · 오포글리프론 (국내 승인 전)

식사·물과 관계없이 **하루 한 번 아무 때나**. 기다릴 필요가 없는 대신 처음에 위장이 적응하는 기간이 필요합니다.

Tip · 기존 약을 드시는 분은 지금처럼 빈속 + 30분 기다리기를 그대로 지키세요.

근거 · ACHIEVE-3 연구 계획서 · 경구 세마글루타이드 허가사항

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1,698명을 1년간 — 두 약을 정면으로 겨룬 연구

같은 조건의 환자를 무작위로 나눠 두 약을 직접 비교했습니다

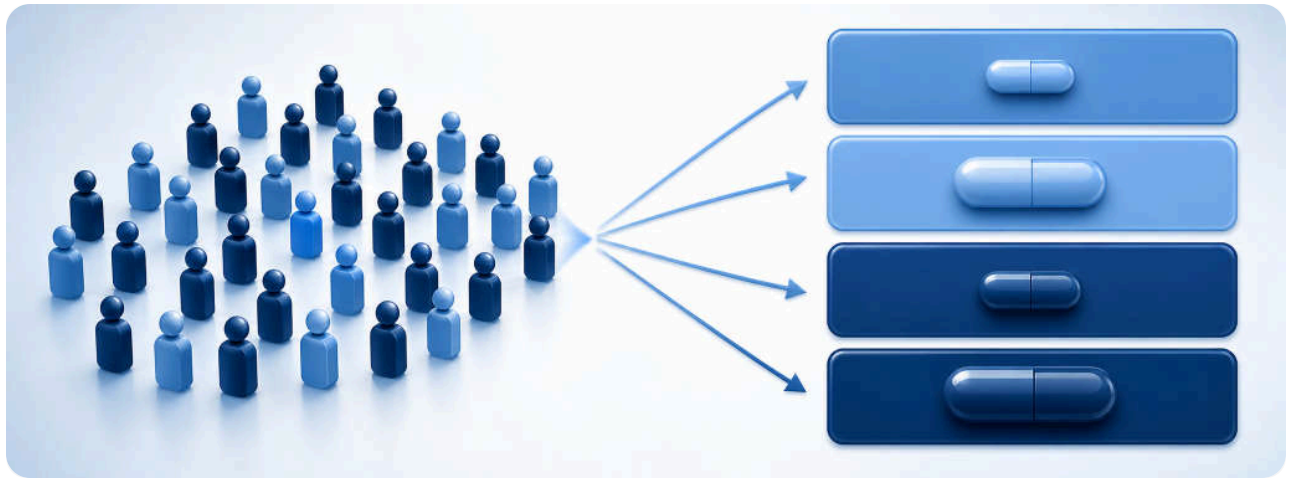


그림 · 참가자를 네 가지 용량 그룹에 같은 인원으로 무작위 배정했습니다(설명용 그림).

해당하지 않는 분 1형 당뇨와 임신부는 이 연구에 포함되지 않았습니다.

1,698명 **5개국 131개 병원**
네 그룹에 무작위 배정

52주 **1년 추적**
당화혈색소 변화가 1차 결과 (시작 평균 8.3%)

대상 메트포르민만으로 혈당이 잘 안 잡히는 성인 2형 당뇨 (당화혈색소 7.0~10.5%, 과체중 이상). 한국인 별도 자료는 아직 없습니다.

Tip · 의사·환자 모두 어떤 약인지 알고 진행한 연구입니다(눈가림 없음) — 한계는 10장에서 봅니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3) · 일라이 릴리 후원

네 그룹 모두 내렸지만, 내린 폭이 달랐습니다

당화혈색소의 1년 변화량 (시작 평균 8.3%) — 막대가 길수록 많이 내린 것



어떻게 읽나요

막대 길이는 실제로 내린 폭에 비례합니다. 네 그룹 모두 의미 있게 내렸습니다.

같은 단계끼리 보면

신약이 같은 단계 용량의 기존 약보다 더 많이 내렸습니다 — 차이는 다음 장에서 봅니다.

Tip · 주황 막대가 신약, 남색 막대가 기존 먹는 약입니다.

근거 · ACHIEVE-3 1차 결과 (52주)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

차이는 얼마나 컸나

'적어도 비슷한가'를 먼저 확인한 뒤, '더 좋은가'까지 통과했습니다

0.44%p

신약 36mg vs 기존 약 14mg

신약이 당화혈색소를 더 내린 폭

0.24%p

신약 12mg vs 기존 약 14mg

낮은 단계 신약도 높은 단계 기존 약보다 더 내림

4/4

용량 조합 비교

네 가지 조합 모두에서 신약이 앞섰습니다

우연이 아닌 차이

36mg과 14mg의 차이는 통계적으로 분명했습니다. 다만 개인마다 효과 크기는 다를 수 있습니다.

좋은 소식은 여기까지

효과가 더 큰 만큼 치러야 할 대가도 있습니다 — 다음 장에서 부작용을 함께 봅니다.

Tip · %p(퍼센트포인트)는 당화혈색소 숫자 자체가 더 내려간 폭입니다.

근거 · ACHIEVE-3 · 36mg 대 14mg 차이 0.44 (95% 신뢰구간 0.26~0.62)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

공짜는 없습니다 — 효과의 대가도 함께 봅니다

대부분 가볍고 시간이 지나며 줄어듭니다 — 다만 빈도는 신약이 더 높았습니다

위장 증상

메스꺼움·설사 등 — 신약 100명 중 58~59명, 기존 약 37~45명. 대부분 가벼운~중간 정도입니다.

처음 몇 주에 몰립니다

위가 약에 적응하는 시기에 주로 생기고, 천천히 용량을 올리면 줄일 수 있습니다.

약을 끊은 비율 약 2배

신약 100명 중 9~10명, 기존 약 4~5명. 천천히 올리면 줄일 수 있습니다.

맥박이 조금 빨라짐

분당 약 4~5회 증가(기존 약 1~1.5회) — GLP-1 계열에서 공통으로 알려진 변화입니다.

이런 분은 미리 상담

두근거림이 잦거나 심장질환·부정맥이 있다면 시작 전에 꼭 의사와 상의하세요.

참지 말고 알리기

힘들면 용량 조절·중단 같은 선택지가 있습니다 — 진료실에서 함께 해결합니다.

Tip · 빈도는 반올림한 대략적인 숫자입니다.

근거 · ACHIEVE-3 안전성 분석 (투약군 전체)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이 연구, 그대로 믿어도 될까 — 한계 네 가지

약 이야기는 여기까지 — 연구의 한계를 함께 봅니다

01

눈가림 없음

의사도 환자도 어떤 약인지 알고 진행했습니다 — 주관적인 평가가 치우칠 수 있습니다.

설계의 한계

02

제조사 후원

신약 개발사(일라이 릴리)가 비용을 댄 시험입니다 — 독립적인 검증이 더해져야 합니다.

해석에 주의

03

52주 — 장기 자료 아님

심혈관 보호 효과와 수년 단위 안전성은 이 시험으로 알 수 없습니다.

별도 연구 진행 중

04

체중 효과는 물음표

'살 빠지는 약'으로 기대하기 쉽지만, 공개된 요약에는 체중 수치가 없습니다.

아직 모릅니다

Tip · 가장 중요한 사실 — 오포글리프론은 아직 국내 미승인입니다. 처방·구매가 안 되고, 해외 직구는 안전을 보장할 수 없습니다.

근거 · Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3) · 식약처 허가 현황(2026-06)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

그래서, 오늘 할 일은 의외로 단순합니다

새 약을 기다리는 가장 좋은 방법은 지금 치료를 잘 유지하는 것입니다

01 드시던 당뇨약·인슐린을 마음대로 끊거나 줄이지 않기

02 국내 미승인 약 — 광고·해외 사이트에서 사지 않기

03 기존 먹는 약(세마글루타이드)은 빈속 + 30분 기다리기 그대로

04 식전·식후 혈당을 기록해 다음 외래에 가져오기

05 구역·구토·설사가 심하면 참지 말고 연락하기

06 이번 주 생활 습관 하나 — 예: 한 끼 채소 한 주먹, 식후 10분 걷기

07 신약 승인·처방 가능 여부는 진료 때 의사와 상의하기

Tip · 승인 소식은 저희가 챙겨 알려 드립니다.

근거 · 광교바른내과 당뇨 외래 실천 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 GLP-1 시대는 오고 있습니다

아직은 준비 단계 — 그 사이 가장 좋은 약은 지금 잘 유지하는 치료입니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

먹는 GLP-1 신약 연구 결과를 궁금해하는 당뇨병 환자와 가족을 위한 설명자료입니다. 오포글리프론은 아직 국내 승인 전이며, 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Rosenstock 등, 란셋 2026;407:1147-60 (ACHIEVE-3 · 일라이 릴리 후원) · 대한당뇨병학회 당뇨병 팩트시트 · 경구 세마글루타이드 허가사항

이 자료 다시 보기